SDD 54 Sujet n°1

Spécialité : Néphrologie

Date :13/12/24
Auteur : PLUM Ariane (DES néphrologie - EDN 2024)

Relecteur(s) : RUBIN Hélène (DES néphrologie - EDN 2024)

Domaine d'apprentissage principal	Entretien/interrogatoire
Domaine d'apprentissage secondaire	Examen clinique
Items en lien avec la station	257 : Œdèmes des membres inférieurs localisés ou généralisés 259 : Protéinurie et syndrome néphrotique chez l'adulte 227 : Insuffisance veineuse chronique. Varices
Situation de départ en lien avec la station	54 : Œdèmes localisés ou diffus
Matériel nécessaire à la station	Aucun
Contexte de la station	Mme P, 57 ans, se présente en consultation de médecine générale pour sensation de jambes lourdes et gonflées.

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes interne de médecine générale
Vous recevez au cabinet Madame P, âgée de 57 ans qui vient pour une sensation de jambes lourdes et gonflées. C'est la première fois que vous voyez Madame P.

Consignes :

Vous devez :
- Réaliser l'interrogatoire ciblé de la patiente.
- Réaliser un examen clinique ciblé en décrivant ce que vous cherchez.

Vous ne devez pas :
- Prescrire d'examen complémentaire.
- Proposer une prise en charge thérapeutique.

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

ECOS TACFA
GRILLE D'ÉVALUATION

Aptitudes cliniques (max 15 items)			
1.	Se renseigne sur au moins 2 éléments du mode de vie : consommation d'alcool chronique, tabagisme, régime alimentaire restrictif, profession, voyage récent.	1 pt	☐
2.	Se renseigne sur au moins 2 antécédents personnels parmi : pathologies cardiovasculaires, maladie rénale, pathologies hépatiques, insuffisance veineuse, thrombose veineuse profonde ou superficielle.	1 pt	☐
3.	Demande les traitements habituels ET recherche une automédication.	1pt	☐
4.	Se renseigne sur l'historique des œdèmes : premier épisode versus récidive ET la rapidité d'installation.	1 pt	☐
5.	Recherche au moins 2 facteurs possiblement aggravant les œdèmes (station debout prolongée, fin de journée, chaleur…)	1 pt	☐
6.	Recherche si les œdèmes sont uni- ou bilatéraux.	1 pt	☐
7.	Recherche les autres caractéristiques cliniques des œdèmes (au moins 2 éléments) : - Blancs ou inflammatoires - Mous ou indurés - Indolores ou douloureux - Prenant le godet ou non	1 pt	☐
8.	Demande le poids actuel de la patiente ET le poids de forme	1 pt	☐
9.	Demande la pression artérielle.	1 pt	☐
10.	Recherche au moins 2 autres signes de surcharge hydrosodée : turgescence jugulaire, reflux hépato-jugulaire, ascite, diminution du murmure vésiculaire ou crépitants à l'auscultation pulmonaire.	1 pt	☐
11.	Recherche au moins 2 signes cliniques d'insuffisance hépatique ou d'hypertension portale : angiomes stellaires du tronc, ictère, ongles blancs, érythrose palmaire, ascite, splénomégalie, circulation veineuse collatérale abdominale.	1pt	☐
12.	Demande si la patiente a constaté du sang dans les urines.	1pt	☐
Communications et attitudes			

1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

2. APTITUDE À QUESTIONNER

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

4. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

9. APTITUDE À STRUCTURER L'EXAMEN CLINIQUE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
L'examen clinique est incomplet et désorganisé ou ne fait pas l'examen clinique	Les éléments recherchés sont peu ciblés, s'attarde à des manœuvres inutiles	L'examen clinique est raisonnablement organisé et couvre les éléments essentiels	L'examen clinique suit un enchaînement logique et est centré sur le problème, il n'y a pas de manœuvre inutile	L'examen est réalisé sans erreur avec un but précis, démarche intégrée

TOTAL	/16 pt

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ OU PROFESSIONNEL DE SANTÉ

Consignes génériques pour le patient ou PSS :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat (contexte de la station) :

Femme de 57 ans qui consulte son médecin généraliste pour sensation de jambes lourdes et gonflement des membres inférieurs.

Plan de la station ECOS :

Assis face à l'étudiant.

Phrase de démarrage du patient simulé ou du PSS :

Bonjour docteur, je viens vous voir parce que je suis embêtée : j'ai les jambes qui ont grossi, je suis serrée dans mes chaussures.

Identité du patient :

Madame P, femme de 57 ans
162 cm
Poids ancien : 58 kg avec prise de 5 kg en 2 semaines, poids actuel : 63 kg
IMC actuel = 24 kg/m²

Mode de vie

Directrice des services informatiques. Travail plutôt sédentaire.
Mariée, 2 enfants de 25 et 23 ans.
Pas d'intoxication alcoolo tabagique. Aucun autre toxique.
Régime végétarien.
Pas d'animaux à domicile. Pas de voyage récent.

Comportement global :

Patiente stressée par ses symptômes qui la gênent.

Antécédents personnels :

Fracture du poignet droit après une chute de ski il y a 10 ans.
Hypertension artérielle de découverte récente, il y a 1 mois à 151/92 mmHg.
Pas d'autres maladies, notamment aucun problème de foie, pas de maladie cardiaque ou rénale, pas d'ulcère ou de plaie des membres inférieurs, pas d'insuffisance veineuse.

Antécédents familiaux :

Cancer du sein chez la mère à 78 ans.
Diabète de type 2 chez le père vers 63 ans.

Médicaments :

RAMIPRIL 2,5 mg le matin.

Allergie :

Aucune.

Symptômes et signes physiques positifs :

Œdèmes bilatéraux blancs mous indolores prenant le godet.

Symptômes et signes physiques négatifs :

Pas de douleur thoracique, pas de signes d'insuffisance cardiaque. Bruits du cœur réguliers sans souffle.
Patiente non dyspnéique, auscultation pulmonaire normale.
Pas d'ascite, pas de splénomégalie, pas de circulation veineuse collatérale.
Ongles et peau de couleur normale.
Pas de signe d'inflammation locale au niveau des membres inférieurs.
Pas de varice, pas de cicatrice d'ulcère
Pas d'hématurie macroscopique.

Mode d'apparition, ancienneté et évolution des symptômes :

Œdèmes bilatéraux apparus depuis 2 semaines environ, d'apparition rapidement

progressive.
Pas de facteurs d'aggravation, ni de facteur améliorant.

Constantes :

PA 170/ 96 mmHg, Fc 73 bpm, FR 16 cycles/min, Sp02 98%

ECOS TACFA

FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Plan de la station ECOS :

Patient assis face à l'étudiant
Un bureau 2 chaises

Matériel nécessaire à la station :

- Feuille de brouillon pour candidat
- Stylo pour candidat
- Feuille de brouillon pour évaluateur
- Stylo pour évaluateur

Documents présents dans la station :

- Feuilles d'évaluation de papier de secours.